



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سلوى جمال سيد عبد الفتاح

العنوان : البحارى

الحي / المدينة : الفيوم

المحافظة : الفيوم

تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

رقم البطاقة : 28105012300524 رقم التليفون : 01004797304

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-05-1981 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه
التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة:
الوظيفة:
الوظيفة:

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/ د/ د/ د/

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :

قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سلوى جمال سيد عبد الفتاح National ID: 28105012300524	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدى و تحتاج الى Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢٣/٠١

٢٨١.٥.١٢٣.٠٥٢٤

بهم صناعة

مترجمة

سليمة

إلى منظم الخط عبد المجيد

٢٠٣٠/٠٧/٢٤ حتى

الطابق سارية حتى



جدة لوزي نيرة فاضلة المرحوم نيرة
بمطابق تحقيق الشخصية

سلي

جمال سيد عبد الفتاح

دار الرمال

اول القويم - القويم

٢٨١.٥.٠١٢٣.٠٥٢٤



JV8181433

Name : salwa gamal sayed
 Branch : Portable
 Ref.Physician Prof :

Date : 05-01-2026 03:07
 Medical No. : GRI-10478
 Ins.Company :

MULTI-SLICE NON-CONTRAST MDCT SCAN OF THE BRAIN WITH RECONSTRUCTION
IMAGES REVEALED:

FINDINGS:

- No focal cerebral area of abnormal density seen.
- Preserved normal gray-white matter interface.
- No extra-axial or intra-cerebral areas of fresh blood densities.
- Normal size and configuration of the ventricular system.
- No midline shift.
- Unremarkable posterior fossa structures.

OPINION:

- *Normal non-enhanced CT scan of the brain.*

MULTISCLICE NON CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

I- CHEST:

- Tiny right upper lobe calcified nodule measuring 3 mm.
- Left upper lobar subpleural reticulations likely post therapeutic sequel.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.

Name: MR. :	سلوى جمال 4358	
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	
	رقم طبي:	
إيماء للطلب المقدم من بقسم:		
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	
تاريخ وساعة الدخول :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient underwent a CT chest-abdomen-pelvis on 5 January 2026, which demonstrated a D6 sclerotic bony lesion; a bone scan was subsequently performed. The patient presented for administration of Zoladex on 10 August and tamoxifen, with supplemental therapy planned for three months. A repeat CT chest-abdomen-pelvis on 1 March 2026 raised concern for a possible D9 lesion. The plan was to obtain a bone scan and to continue Zoladex and tamoxifen on the same day. On 7 April 2026 the patient had a bone scan performed on 3 May 2026, which was reported as free of disease. The patient received Zoladex and tamoxifen on the same day, with tamoxifen prescribed as CALCIUM 1 × 1 × 90 and a single dose of ONE ALPHA. On 5 May 2026 the patient's history was reviewed: left-sided breast cancer diagnosed in October 2020, treated with upfront wide-local excision revealing invasive ductal carcinoma grade 2, T2 N0 (0/2 nodes), estrogen and progesterone receptor positive, HER2 negative, Ki-67 5 %. Adjuvant therapy included cyclophosphamide, doxorubicin, and taxol, followed by tamoxifen and Zoladex initiated in June 2021. The patient received tamoxifen and Zoladex today for three months, with a plan to obtain Zometa from the pharmacy and repeat laboratory studies next month. The most recent CT in January 2026 showed a D6 sclerotic lesion, which was confirmed to be absent on the bone scan performed in March 2026. The next clinic appointment will assess whether hormonal therapy can be discontinued after five years of continuous treatment. The patient has completed five years of combined tamoxifen and Zoladex therapy and is now 45 years old. She was initially staged as T2 N0 grade 2, premenopausal, intermediate risk. The current recommendation is to discontinue Zoladex and continue tamoxifen alone, with assessment of FSH and estradiol levels after four months to determine whether to switch to an aromatase inhibitor or maintain tamoxifen based on menopausal status. The patient's current complaints are primarily bony aches.		
تحريراً في ,		
	التاريخ : 20-09-2026 الوقت :	
Reham Ahmed Fathy Ibrahim		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Name : salwa gamal sayed

Branch : Portable

Ref.Physician Prof :

Date : 05-01-2026 03:07

Medical No. : GRI-10478

Ins.Company :

- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- D9 vertebral body sclerotic lesion

Opinion:

- ❖ Right upper lobe tony calcified nodule likely post previous inflammatory sequel.
- ❖ Left upper lobar subpleural reticulations likely post therapeutic sequel.
- ❖ D9 vertebral body sclerotic lesion for bone scan to exclude metastatic possibility.

Dr. Asser Ahmed

Dr. Asser Ahmed

Patient Name : الأستاذ / ملوى جمال سيد عبدالفتاح
Patient No. : 28105012300524
Path No. : SR-783/21
Sex : Female
Age : 40 Y
Referring Doc :
Request No. : 139504
Request Date : 29/11/2021
Verification Date : 11/12/2021
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient

Pathology Report

Clinical Data:
Lt breast mass
Nature of the specimen:
Slide revision
Gross Examination:
One block (1795), & 7 slides.

Microscopic examination:
Histological type: IDC
Grade II
Angioinvasion: no
Ductal carcinoma in situ: positive
Lymph node status: 0/2
Free margins

Diagnosis:
Lt breast mass, tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma GII.
ER: moderate nuclear staining in 10% of tumor cells (score 4/8)
PR: strong nuclear staining in 50% of tumor cells (score 7/8)
Her2: Negative (score 0)
Ki67: 10% nuclear reaction

Prof. Gamal AbdelAty
Dr.Rana Fathy

Professor
Reham Shehab El-Nemr
A. Professor of pathology
Faculty of Medicine
Fayoum university
FOC



دكتور
محافظه الفيوم
الجمعية العلمية
أستاذة في الطب
عضو الجمعية المصرية
المسجلة برقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٠

مركز ألام الفيوم
Patient's Name : سلوى جمال سيد

Age: 39 years.

Referring Doctor: Prof. Dr. A. Kamal.

Code: F910/20

Pathology Report

Specimen: Left breast mass.

Gross Description: Grayish white core 1 cm. long.

Microscopic Description: Sections examined revealed a breast core showed infiltrating malignant ductal cells disposed in angulated tubules, with the anaplasia in desmoplastic stroma.

Focal dilated duct with intraductal malignant cells disposed in cribriform pattern is seen.

Diagnosis:

LEFT BREAST MASS:

MINIMALLY REPRESENTED INVASIVE DUCT CARCINOMA, WITH TUBULAR DIFFERENTIATION AND FOCAL INTRADUCTAL CARCINOMA.

P.O: slides enclosed.

A. Prof. Dr. Reham Shehab, MD

14/9/2020

الفرع الرئيسي : ش. جمال عبدالناصر - برج الأندلس - خلف فندق الشلي داي - بجوار مركز العيد للأشعة
فرع المسيلة : ميدان المسيلة - أعلى مطعم روستو - الدور الثالث الهاتف : 01062015165 - 0100 53 49 52 4

بنوان : إمتداد ش النبوي المهندس - خلف مستشفى الصدر - الفيوم - مصر

ليفون : ٨٤٢١٨٤١٧٤ - محمول : ٠١٠٦٩١٠٤٥

لبريد الإلكتروني : foc600600@gmail.com



التاريخ :- 2020/9/3

محافظة الفيوم - مديرية التضامن الإجتماعي
الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام
اسم المريض :- جمال سيد
سلوى محمد شهابية برقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٠
الطبيب المعالج :- د. عمرو دمال

Sono-mamography examination of Bilateral Breast Revealed

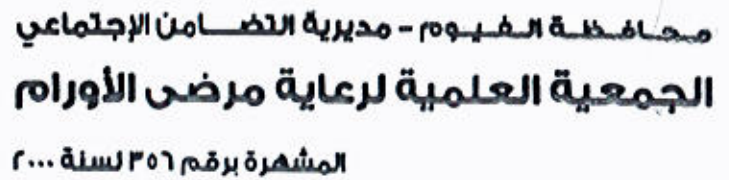
ACR B: Scattered fibroglandular breast tissue

Right breast:-

- A well-defined rounded hypoechoic soft tissue mass lesion is seen at 1 o'clock measuring about (0.6 X 0.6 cm) in its maximum transverse diameters. Such lesion showed no areas of breaking down, calcifications or vascularity on color Doppler study.
- Normal appearance of lactiferous ducts with no evidence of focal lesions within.
- No abnormal vascular pattern.
- Average skin thickness.
- Normal appearance of retro-mammary area and pectoral muscles.
- No intra-mammary Lymphadenopathy.
- Nonspecific axillary lymph nodes are noted. They showed regular outlines and preserve fatty hilum.

left breast:-

- At the site of patient complaint two irregular shaped hypoechoic soft tissue mass lesions are seen at 6 o'clock retroareolar, measuring about (0.65 X 0.6 cm) & (1.2x1.5 mc) in maximum transverse diameters. Such lesions showed internal vascularity on color Doppler study.
- Normal appearance of lactiferous ducts with no evidence of focal lesions within.
- No micro/macro-calcifications detected.
- Average skin thickness.
- No abnormal vascular pattern.
- Normal appearance of retro-mammary area and pectoral muscles.
- No intra-mammary Lymphadenopathy.
- Nonspecific axillary lymph nodes are noted. They showed regular outlines and preserved fatty hilum.



- *Left breast two suspicious soft tissue mass lesions for biopsy (BIRADs IV-c).*
- *Right breast soft tissue mass lesion likely fibro-adenoma (BIRAD-II).*
- *Bilateral nonspecific axillary lymph nodes.*

Yours sincerely
DR/ Nehal Suleh
MSC



Patient's Name: -Salwa Gamal Sayed

Date:-19/07/2022

Conclusion:

A reported case of pathologically proven operated breast carcinoma, at follow up showing:-

- No sizable operative bed metabolically active (FDG avid) masses.
- Few subcentimetric low grade bilateral axillary lymph nodes; for U/S correlation and close follow up.
- No evidence of metabolically active (FDG avid) distant metastatic deposits.

Best Regards;

Dr. Mohammed Mohsen, MSc

Dr. Ayman Abo El-Regal; M.D

Radiology consultant- NCI - Cairo University

Prof Dr. Khaled Elshantaly

Professor of radiology Cairo University



Patient Name: Salwa Gamal Sayed Abd Al Fattah	Date : 05/11/2024
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 5002/2020	Pat. ID: 10478

NON- CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

Known case of left CBS with evidence of axillary intervention :

- Left retro-areolar parenchymal distortion with nipple retraction associated with thickened soft tissue sheets related to left pectorals muscle and minimal skin thickening , for SM correlation.
- Left upper lobe subpleural reticulation and coarse interstitium likely post radiotherapy sequel
- Few bilateral axillary level I prominent lymphnodes
- Few bilateral tiny subpleural pulmonary nodules are seen 2-3 mm
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definite enhancing focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.



Patient Name: Salwa Gamal Sayed Abd Al Fattah	Date : 05/11/2024
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 5002/2020	Pat. ID: 10478

***Scanned skeleton:** no definite bone marrow lytic or sclerotic lesion could be seen by CT criteria

Opinion:

- Left breast BCS with post operative scarring , for clinical and SM correlation
- No evidence of pulmonary or hepatic ,etasttaic lesions on non contrast study basis.

Dr/Reem Elwaly

Dr. Walid Mohamed, M.D.

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
رد دعم القرار

تاريخ الإصدار: 2023-5-11

جهة الإصدار: فرع اليوم

الن من وجهة الأمر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للتأمين: الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "التأمين الشاملة والمعاشات والإعارة" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنة 2012 "الإعارة من المن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة الصغيلة. وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي والبحث تبين أن

السيد (5) مكي جمال سيد عبد الفتاح بطاقة رقم 28105012300524
و طبقا للمخطبات من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الأتباع
وتبين من القوائم غير المتكاملة بالتأمين الصحي عدد هذا الخطيب: الذين أي مسئولية على الهيئة
العامة للتأمين الصحي حال تنوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطابعة: 2023-5-11

الموظف المختص

تمرق محمد

الإدارة مركز نظم المعلومات
بمكتب

مستند 397100



الخطيب على لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التأمين الاجتماعي أو وزارة الترقية والتوظيف

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات رد دعم القرار